



קבוצה	אנטגוניסט־נרקוטי
מנגנון הפעולה	נרקן הוא אנטגוניסט תחרותי בעל אפיניות גבוהה ביותר לרצפטורים אופיאטים ב־CNS. כשניתן למטופל, הנרקן מתחרה עם מולקולת האופיאט על הרצפטור ומונע את פעולתו. הנרקן מסונתז מה־paramorphine (Thebaine) – זוהי מולקולה דומה מאוד למורפין אך בניגוד אליה גורמת לאפקטים מעוררים. מולקולת הנרקן דומה מאוד למולקולה של oxymorphone (אופיאט אנלגטי סינטטי פוטנטי) פרט להחלפה של קבוצה כימית אחת (N-methyl) בקבוצה אחרת (allyl) ומכאן למעשה נגזר שמו – N-allyl and oxymorphone.
פרמקוקינטיקה	תחילת ההשפעה עד 2 דקות. שיא ההשפעה לאחר 2–5 דקות. משך ההשפעה עד 20 דקות.
התוויות לשימוש	מינון־יתר של אופיאטים.
התוויות־נגד	רגישות ידועה לנלוקסון או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים.
תופעות לוואי	שינוי במצב הרוח; הזעה; בחילות; הקאות; עצבנות יתר; פרכוס.
מינון	מבוגרים – מתן ב־0.4–2 mg I.V. מהול ב־10 ml סליין. – מתן I.N. – 2 mg במנות חוזרות של 0.4 mg. – אפשר לחזור על המנה לאחר 3–5 דקות (I.V) או 10 דקות (I.N) במקרה הצורך. מינון מקסימלי מצטבר 10 mg. ילדים – מתן ב־I.V. – – עד משקל 20 ק"ג – 0.1 mg/kg עד מנה מקסימלית של 2 mg (מהול ב־5 ml סליין בהזרקה איטית). – מעל משקל 20 ק"ג – 2 mg (מהול ב־5 ml סליין בהזרקה איטית). – יש להפסיק את הטיפול עם הופעת סימני שיפור במצב ההכרה והנשימה. – מתן ב־I.N. – – 2 mg (במנות חוזרות של 0.4 mg עד השגת אפקט רצוי). – במקרה הצורך אפשר להזריק מנה נוספת לאחר 5–10 דקות.
צורות מתן במד"א	I.V , I.N
מופיע בפרוטוקול	<u>שינויים במצב ההכרה; שינויים במצב ההכרה בתינוקות ובילדים</u>